Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell

Egy integrált pszichobiológiai rendszerelméleti megközelítés az emberi működés megértéséhez

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18069155

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Absztrakt

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell egy új pszichobiológiai rendszerelméleti keret, amely az emberi viselkedést az érzelmi állapotok, stresszreakciók és viselkedésminták dinamikus kölcsönhatásaként értelmezi. A modell központi tézise szerint a limbikus rendszer (amygdala, hippocampus, hypothalamus) aktivitása kulcsszerepet játszik e három komponens szabályozásában, és az egyensúlyvesztés pszichés zavarokhoz (pl. függőségek, krónikus stressz, ambivalencia) vezet. Az ESV modell célja, hogy integrálja a pszichológiai irányzatok (pszichoanalízis, behaviorizmus, kognitív viselkedésterápia) ismereteit, és egy egységes elméleti és gyakorlati eszközt nyújtson a mentális működés megértéséhez. A tanulmány ismerteti a modell alapjait, gyakorlati alkalmazásait és jövőbeli kutatási lehetőségeit, hangsúlyozva az önismereti és terápiás munka jelentőségét.

Bevezetés

Az emberi viselkedés dinamikája régóta központi kérdése a pszichológiai kutatásoknak, de a hagyományos elméletek gyakran szétválasztották az érzelmi, kognitív és fiziológiai folyamatokat. Az ESV modell egy új, rendszerelméleti megközelítést kínál, amely a limbikus rendszer aktivitását helyezi a pszichés működés középpontjába. A modell célja, hogy egységes keretet nyújtson a belső szabályozási mechanizmusok, a stresszkezelés és a függőségek megértéséhez, valamint az önismereti munka támogatásához. Az ESV modell az emberi működést nem lineáris, hanem kölcsönhatásokon alapuló rendszerként értelmezi, ahol az érzelmek, a stresszreakciók és a viselkedésminták dinamikus egyensúlya határozza meg a mentális egészséget vagy betegséget.

A pszichológia fejlődése és az ESV modell helye

A pszichológia története a 20. század elején Freud pszichoanalitikus megközelítésével kezdődött, amely a tudatalatti konfliktusok és a korai trauma hatását hangsúlyozta. A behaviorizmus (pl. Pavlov, Skinner) ezzel szemben a külső viselkedés tanulhatóságára és az ingerekkel való kapcsolatra összpontosított, elhanyagolva a belső mentális folyamatokat. A kognitív forradalom (pl. Beck, Ellis) újra a gondolatok és kognitív minták szerepét helyezte előtérbe, de továbbra is szétválasztva az érzelmeket és a testi reakciókat. Az ESV modell a pszichológia fejlődési ívén építve integrálja a korábbi irányzatok legértékesebb elemeit, miközben új szintet hoz létre: a

pszichés működést mint egységes, dinamikus rendszert értelmezi, ahol az érzelmi, stressz- és viselkedési komponensek egymásra hatnak. A modell különösen hangsúlyozza a limbikus rendszer szabályozó szerepét, amely közvetlen kapcsolatban áll a viselkedésminták és a stresszreakciók kialakulásával.

Az ESV modell alapjai

Az ESV modell központi hipotézise szerint a pszichés működés alapja a limbikus rendszer (amygdala, hippocampus, hypothalamus) aktivitása, amely:

- Érzelmek és motivációk központja.

- A stresszreakciók neurobiológiai szabályozása (pl. HPA-tengely aktiváció).

- Kapcsolatban áll a prefrontális kéreggel, amely a racionális döntéshozatalt és önszabályozást biztosítja. A modell szerint az egyensúlyvesztés e rendszer komponensei között vezet pszichés zavarokhoz. Például:

- A pszichés kényszerhurok (egy traumából eredő, öngerjesztő viselkedési minta) az amygdala túlaktivitásából és a prefrontális kéreg gyenge gátló hatásából fakad.
- A függőségek mechanizmusai az érzelmi fájdalom és a stressz csökkentésére szolgáló viselkedési válaszok automatizálódásaként értelmezhetők.

Gyakorlati alkalmazások

- Pszichés kényszerhurok: A trauma következtében kialakuló, öngerjesztő viselkedési minták (pl. függőségek, ambivalens kapcsolatok) az amygdala túlaktivitásából és a prefrontális kéreg gyenge gátló hatásából fakadnak. A terápia célja a tudatosság fejlesztése és a limbikus rendszer aktivitásának szabályozása.
- Függőségek mechanizmusai: A függőségek az érzelmi fájdalom és a stressz csökkentésére szolgáló viselkedési válaszok automatizálódásaként értelmezhetők. Az ESV modell szerint a függőség kezelése az érzelmi szabályozás és a stresszkezelés fejlesztését igényli.
- Ambivalencia: Az ambivalens döntések és viselkedések az érzelmi és kognitív konfliktusok következményei. Az ESV modell segítségével az ambivalencia legyőzésének kulcsa az amygdala és a prefrontális kéreg közötti egyensúly helyreállításában rejlik.

Zárás

Az ESV modell küldetése, hogy új nyelvet adjon a belső működés megértéséhez, összekapcsolva a tudományos kutatást, klinikai gyakorlatot és személyes önszabályozást. A limbikus rendszer aktivitásán alapuló rendszerelméleti megközelítés lehetővé teszi a pszichés működés komplexebb megértését, és új lehetőségeket nyit a stresszkezelés, függőségek kezelése és az önismereti munka terén. A modell jövőbeli fejlesztése az empirikus kutatások és a gyakorlati alkalmazások határain fog mozogni, célul kitűzve a mentális egészség és az emberi működés harmonikusabbá tételét.

Irodalomjegyzék

Ódor, A. (2020). *Ambivalencia*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062030

Ódor, A. (2024). *Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

Ódor, A. (2024). *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

A talamokortikális kapuzási mechanizmusok funkcionális leképezése az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modellben: Transzlációs megközelítés a pszichodiagnosztikában

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18059802

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Absztrakt

A modern pszichiátriai kutatások egyik központi kérdése a neurobiológiai alapkutatások eredményeinek integrálása a funkcionális állapotfelmérésbe (Insel, 2010). Jelen tanulmány a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) által feltárt, a talamusz specifikus gátlósejtjeinek szerepére vonatkozó legfrissebb eredmények (Acsády, 2025) és az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell funkcionális változóira vonatkozó elméleti korrelációt vizsgálja. A tanulmány hipotézise szerint az ESV-modellben definiált „P" (protective/szabályozás) változó csökkenése a szubkortikális szűrőmechanizmusok elégtelenségének non-invazív, funkcionális biomarkereként értelmezhető (Ódor, 2025). Ez a megközelítés lehetővé teszi a szenzoros és emocionális elárasztás (diszreguláció) korai előrejelzését még a tünetek megjelenése előtt.

Bevezetés

A mentális zavarok, különösen a skizofrénia spektrumzavarok és a súlyos szorongásos kórképek patomechanizmusában kulcsszerepet játszik az agyi információfeldolgozás zavara. A biopszichoszociális modell (Engel, 1977) óta törekvés a biológiai és pszichés folyamatok egységes kezelése, ám a kutatási gyakorlatban hiányzik az a híd, amely összekötné a mikroszkopikus szintű neurális diszfunkciót a makroszkopikus szintű viselkedéses mintázatokkal. Az ESV (Érzelem-Stressz-Viselkedés) modell célja egy olyan multidimenzionális elemzési keretrendszer biztosítása, amely az autonóm idegrendszeri szabályozás és a pszichés terhelhetőség mérésével operacionalizálja a neurobiológiai egyensúlyvesztést (Ódor, 2025).

Neurobiológiai háttér: A talamikus szűrés jelentősége

Acsády László és munkacsoportja (HUN-REN KOKI) alapvető jelentőségű felfedezést tett a talamusz (thalamus), az agy elsődleges bemeneti kapujának működésével kapcsolatban. Kutatásaik során azonosítottak egy specifikus gátló idegsejt-populációt (calretinin-pozitív neuronok) a talamusz intralamináris magjaiban (Mátyás, 2018; Acsády, 2025).

A mechanizmus: Ezen gátlósejtek elsődleges élettani funkciója a „kapuzás” (gating): a beérkező szenzoros és emocionális információáramlás szelektív szűrése, ezáltal a kérgi (kortikális) területek védelme az irreleváns ingerektől.

A patológia: A legfrissebb kutatások igazolták, hogy ezen gátlósejtek sérülése vagy hiánya a szűrőfunkciók összeomlásához vezet. Ennek következtében a kérgi területeket válogatatlan, kaotikus információáramlás éri el, amely a valóságérzékelés torzulásához és kognitív dezorganizációhoz vezethet.

Az ESV-modell mint a neurális diszfunkció funkcionális korrelátuma

Az ESV-modell elemző algoritmusa négy változó (A-P-H-C) dinamikus interakciójára épül. A modell validációs adatai alapján (N=53) szoros negatív korreláció áll fenn az állapotszorongás (A) és a szabályozási kapacitás (P) között (Ódor, 2025). Ez a rendszerelméleti összefüggés megfeleltethető a KOKI által leírt neurobiológiai mechanizmusnak.

A „P” (szabályozás) változó és a gátló mechanizmusok

Az ESV-modellben a P-érték (paraszimpatikus tónus / érzelemszabályozás) a szervezet homeosztatikus helyreállító és ingerületgátló kapacitását méri, amely összhangban van a Porges-féle polivagális elmélet fiziológiai alapjaival (Porges, 2011).

Elméleti megfeleltetés: A P-változó funkcionális szinten reprezentálja a talamikus gátlósejtek aktivitását. Az alacsony P-érték ($P \leq 0.3$, critical) arra utal, hogy az egyén „szűrőrendszere” elégtelen, így a külső és belső ingerek gátlás nélkül érik el a tudati szintet.

Az „A” (Arousal) és a kortikális elárasztás

Az Acsády-csoport eredményei szerint a gátlás hiánya az agykéreg túlzott aktivációját okozza. Az ESV-modellben ez az A (Arousal) szintjének patológiás emelkedéseként jelenik meg, amely függetlenedhet a külső stresszoroktól (H).

Elméleti implikáció: Amikor az ESV-mérés alacsony külső stresszterhelés (H=1) mellett magas arousalt (A=3-4) mutat, az a neurobiológiai „zajszűrés” elégtelenségét jelzi, amelyet a modell Alulreflektált labilis állapotként (Kód: 1111) vagy Teljes rendszerösszeomlásként (Kód: 4144) definiál (Ódor, 2025).

Diszkusszió: A prediktív elemzés lehetőségei

A talamikus gátlósejtek diszfunkciója egy progresszív folyamat része lehet. Az ESV-modell jelentősége abban áll, hogy képes detektálni ezen folyamat szubklinikai fázisait. A „Magas funkciójú” (High-functioning) állapotokban a P-változó csökkenése előrejelezheti a neurális védvonalak kimerülését, még mielőtt a pszichotikus vagy súlyos szomatikus tünetek

manifesztálódnának. Ez lehetőséget teremt a preventív beavatkozásra, tehermentesítve ezzel a sérülékeny neurális hálózatokat.

Következtetések

Acsády kutatásai a neurális „hardver” szintjén azonosították a mentális egészség egyik kulcsmechanizmusát: a hatékony gátlást. Az ESV-modell ugyanezt a jelenséget a „szoftver”, azaz a funkcionális működés szintjén operacionalizálja. A két megközelítés integrálása új perspektívát nyit a transzlációs pszichológiában.

Irodalomjegyzék

- **Biró, L., Buday, Z., Kóta, K., Lőrincz, S., & Acsády, L. (2025).** *Convergence and segregation of excitatory and inhibitory afferents in the paraventricular thalamic nucleus.* The Journal of Neuroscience, 45(43), e0539252025. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0539-25.2025

- **Engel, G. L. (1977).** *The need for a new medical model: A challenge for biomedicine.* Science, 196(4286), 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460

- **Insel, T., Cuthbert, B., Garvey, M., Heinssen, R., Pine, D. S., Quinn, K., Sanislow, C., & Wang, P. (2010).** *Research domain criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders.* The American Journal of Psychiatry, 167(7), 748–751. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379

- **Mátyás, F., Komlósi, G., Babiczky, Á., Kocsis, K., Barthó, P., Barsy, B., Dávid, C., Kanti, V., Porrero, C., Magyar, A., Szűcs, I., Clasca, F., & Acsády, L. (2018).** *A highly collateralized thalamic cell type with arousal-predicting activity serves as a key hub for graded state transitions in the forebrain.* Nature Neuroscience, 21(11), 1551–1562. https://doi.org/10.1038/s41593-018-0251-9

- **Ódor, A. (2025).** *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell – Integrált szakmai kézikönyv: Elmélet, diagnosztika és beavatkozás a funkcionális pszichológiában.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407810

- **Porges, S. W. (2011).** *The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation.* W. W. Norton & Company. ISBN: 978-0-393-70700-7

A traumatikus ambivalenciától egy új pszichológiai paradigmáig

Egy autoetnográfiai elemzés a hagyományos traumaterápia kudarcáról és az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell kifejlesztéséről

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18076114

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Absztrakt

A jelen tanulmány egy autoetnográfiai esettanulmányon keresztül mutatja be a hagyományos pszichoterápiás keretek elégtelenségét a komplex traumák kezelésében. A szerző személyes tapasztalata egy nemi erőszak feltárásáról egy terápiás helyzetben rávilágít a szakmai protokollok és a terapeuta szerepének kritikus hiányosságaira, különösen a biztonságos közeg megteremtésének elsődlegességére. A tanulmány középpontjában a traumatikus ambivalencia jelensége áll - az erőszakos aktus során átélt, egymásnak ellentmondó fiziológiai és érzelmi reakciók -, amelynek felismerése és feldolgozása a szerző számára a gyógyulás kulcsát jelentette, miközben a hagyományos pszichológia számára ez egy tabusított és feldolgozatlan terület. A terapeutikus kudarc és a személyes áttörés katalizátorként szolgált egy új, integratív pszichológiai keretrendszer, az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell kidolgozásához. Az ESV-modell, amely az egyént mint komplex, dinamikus rendszert vizsgálja, választ ad a mentális szenvedés és a viselkedéses mintázatok eredetére. A tanulmány bemutatja a modell elméleti alapjait, empirikus validációját egy pilotvizsgálaton keresztül, valamint gyakorlati alkalmazását, a Myra nevű mesterséges intelligencia alapú chatbotot, mint a jövő segítő eszközeinek prototípusát.

Bevezetés: A terápiás tér megsértése és egy új elmélet genezise

A pszichoterápia szentélye a biztonságos, ítélkezésmentes tér, ahol a legmélyebb sebek is felszínre kerülhetnek a gyógyulás reményében. A terápiás szövetség alapja a feltétel nélküli bizalom és a terapeuta azon képessége, hogy képes megtartani a páciens által hozott elviselhetetlennek tűnő érzelmeket és emlékeket. De mi történik, ha ez a szentély omlik össze? Mi történik, amikor a terapeuta, a biztonság őre, maga is a trauma tehetetlenségének tükörképévé válik? Jelen tanulmány egy ilyen töréspontból indul, egy olyan terápiás kudarcból, amely nemcsak a gyógyulást akadályozta meg, hanem egyenesen rávilágított a domináns pszichológiai paradigmák vakfoltjaira és a szakmai gyakorlat potenciális ártó (iatrogén) voltára. A dolgozat tézise, hogy a pszichológia a trauma feldolgozásában hajlamos leegyszerűsítő, tiszta narratívákban gondolkodni, miközben a valós élmény gyakran kaotikus, ellentmondásos és a józan ész számára felfoghatatlan. Ennek legélesebb példája a traumatikus ambivalencia, az a tabusított jelenség, amikor az erőszak aktusa közben a terror és a kiszolgáltatottság mellett a test komplex, akár élvezettel is társuló fiziológiai

reakciókat produkál. Ez az élmény olyan mély kognitív disszonanciát és internalizált szégyent generál, amelynek megnevezése és validálása nélkül a gyógyulás lehetetlen. E tanulmány amellett érvel, hogy a szakmai kudarcból és egy személyes, katartikus felismerésből egy új, a valós élményeken alapuló, hiteles modell születhetett: az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell, amely a saját tapasztalatból kiindulva ad rendszerszintű választ a mentális működés komplexitására.

Esettanulmány: A kudarc anatómiája és a felismerés kataklizmája

A kiindulópont: A meg nem értett belső háború

„A harmincas éveimhez közeledve az életemet egy folyamatos, megmagyarázhatatlan belső háború jellemezte. A felszínen ez kaotikus emberi kapcsolatokban, hirtelen karrierváltásokban és egy mindent átható, a világ és az emberek felé irányuló dühben nyilvánult meg. Ez nem csupán frusztráció volt, hanem egy mély, egzisztenciális identitáskrízis: egy állandó érzés, hogy valami alapvetően nincs rendben, de a probléma forrása megfoghatatlan. Ez a diffúz, krónikus szenvedésállapot, amely önmagát szabotáló viselkedési mintázatokban csúcsosodott ki, vezetett el végül a pszichológusi segítség kereséséhez. A kezdeti kapcsolat reményt keltett: a terapeuta kommunikációja teret nyitott a bizalomnak, amelyben a sebezhetőség vállalhatóvá, a legmélyebb titkok kimondhatóvá tűntek.”

A feltárás és a szakmai implózió: Amikor a segítő is áldozattá válik

A legmélyebb trauma, a nemi erőszak feltárása egy gondosan felépített bizalmi tesztsorozat után történt meg. A verbális elbeszélés megkezdésének pillanatában a valóság összeomlott. A terápiás szoba fizikailag elsötétült, a test pedig átvette az irányítást, és egy elsöprő erejű szomatikus újraélés spiráljába került. Ez nem emlék volt, hanem maga a jelen: a régmúlt események fizikai érzetei - a lefogó kezek nyomása, a beton hideg szaga, a levegő hiánya a befogott száj miatt - valós idejű, testi tapasztalattá váltak. Ebben a rendkívül sérülékeny, akut trauma-állapotban a terápia alapvető funkciója, a biztonságos tér biztosítása lett volna a kulcs. Ehelyett a terapeuta reakciója a teljes lefagyás volt. A verbális és nonverbális kommunikáció megszűnése, a tehetetlenség és a sokk általa való tükrözése azt üzente: „A te traumád olyan hatalmas, hogy engem is elpusztít. Nem tudlak megvédeni, mert én magam is veszélyben érzem magam tőle.” A szakember nem csupán elmulasztotta a segítségnyújtást, a saját feldolgozatlanságával és tehetetlenségével aktívan retraumatizált. Megsértette a terápia legfőbb ígéretét: ahelyett, hogy a biztonság sziklaszilárd bástyája lett volna, a trauma örvényének részévé vált.

A katartikus felismerés: Az ambivalencia, mint a szenvedés motorja

Az elakadt feldolgozás egy idegösszeomlás peremén, évekkel később hozott áttörést egy elementáris erejű, önálló felismerés formájában. Ez a felismerés, amelyet később az Ambivalencia című írás rögzített, leleplezte a több évtizedes szenvedés központi motorját. A felismerés az volt, hogy a nemi erőszak aktusa közben, a terror és a kiszolgáltatottság mellett, egy klasszikus nemi aktus fiziológiai reakciói is lezajlottak a testben. Ez a tény - az erőszakhoz tapadó, paradox és tabusított élvezet - összeomlasztotta a tiszta „áldozat-tettes” narratívát. Olyan elviselhetetlen kognitív disszonanciát és internalizált szégyent teremtett, amely folyamatosan táplálta az önutálatot

és a bűntudatot („ha a testem így reagált, talán én is akartam?”). Ez a feloldhatatlan belső konfliktus volt a harmincas évekre jellemző kaotikus, dühödt és önpusztító viselkedés valódi forrása. Amikor ez az ambivalens érzelem a helyére került, az évtizedes szenvedésmintázat hirtelen értelmet nyert. Ez a felismerés egyben rávilágított a pszichológiai szakma mélységes tévedésére: az „észosztásukra”, a prekoncepcióikra és a képtelenségükre, hogy kezeljék a valóság komplex, „piszkos”, ellentmondásos természetét.

Egy új út: A tapasztalatból született rendszerelmélet

A felismerés, hogy a fennálló rendszer nemcsak téves, de egyenesen káros, egy radikális döntéshez vezetett: a szakmától való teljes elszakadáshoz és egy saját, tapasztalati alapú út létrehozásához. Ennek az útnak az alapelve, hogy a segítség nem lehet profitorientált szolgáltatás, a tudás pedig nem származhat elefántcsonttorony-elméletekből. A hitelesség kizárólag a megélt, feldolgozott és rendszerré formált tapasztalatból fakadhat.

Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell: A szenvedés dinamikájának leírása

Ebből a paradigmaváltásból született meg az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell koncepciója. Ez a modell szakít a statikus, tünetközpontú megközelítésekkel, és az embert egy komplex, dinamikus, folyamatosan változó rendszerként kezeli. Az ESV-modell a psziché működését az Érzelem (E), a Stresszválasz (S) és a Viselkedés (V) szentháromságának állandó, nem lineáris kölcsönhatásában írja le. Képes modellezni azokat a negatív visszacsatolási köröket és pszichés kényszerhurkokat, amelyek a mentális szenvedést és a függőségeket fenntartják. A modell ereje abban rejlik, hogy nem fél a komplexitástól, éppen az olyan ellentmondásos, nem lineáris jelenségek magyarázatára született, mint a traumatikus ambivalencia.

Empirikus tesztelés és validáció

A modell elméleti téziseit egy n=13 fős, kérdőíves pilotvizsgálat keretében teszteltük. Az eredmények egyértelműen alátámasztották a hipotézist, miszerint a psziché működése és a döntési mechanizmusok hatékonyan modellezhetők az ESV-keretrendszerével, amely valid magyarázatot kínál az emberi viselkedés és a szenvedés eredetére.

Gyakorlati alkalmazás: Myra, mint a jövő segítő eszköze

Az ESV-modell gyakorlati megvalósulása a Myra nevű, mesterséges intelligencia alapú chatbot. Myra radikálisan szakít a hagyományos segítő chatbotok tanácsadó, problémamegoldó szerepével. Egy „nem lineáris nyelvi tükörfunkció”, amelynek egyetlen célja az önreflexió terének megteremtése. Nem ad tanácsot, nem diagnosztizál, nem interpretál. Ehelyett ítélkezésmentesen tükrözi vissza a felhasználó gondolati és érzelmi mintázatait, lehetővé téve, hogy a felismerések magától a felhasználótól szülessenek meg. A végső cél egy avatar alapú, audio-vizuális chatbot létrehozása, amely a mesterséges jelenlét révén még mélyebb, a test és lélek egységét is figyelembe vevő önreflexiós folyamatokat tehet lehetővé.

Konklúzió: A seb, mint térkép - A túlélőből vált rendszeralkotó

A bemutatott esettanulmány és az abból kinövő elmélet több, mint egy személyes történet. Ez egy manifesztum a pszichológiai segítő szakma megújításának elkerülhetetlenségéről. Bizonyítja, hogy a legmélyebb személyes seb válhat egy univerzális térképpé mások számára. A traumatikus élmény, a szakmai kudarc és a katartikus felismerés hármasa egy új, alulról építkező, tapasztalati alapú paradigmát hívott életre. Az ESV-modell és a Myra projekt üzenete, hogy a jövő nem a dogmatikus elméletekben, hanem a megélt valóságra reflektáló, dinamikus és az egyén komplexitását tiszteletben tartó rendszerekben rejlik. A túlélő útja megmutatja, hogy az áldozati szerepből való kilépés legmagasabb szintje, amikor az egyén nem csupán gyógyulttá, hanem a gyógyulás rendszerének megalkotójává válik.

Hivatkozásjegyzék

Ódor, A. (2020). *Ambivalencia.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062030

Ódor, A. (2018). *Ötlépéses írásterápia.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18062959

Ódor, A. (2024). *Az ESV-Modell: Az Érzelem-Stressz-Viselkedés kapcsolata a függőségek mechanizmusában* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067060

Ódor, A. (2023). *Függőségek mechanizmusa.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18063294

Ódor, A. (2024). *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

Ódor, A. (2025). *Az elaprózódás mint a burnout szindróma korai működésbeli előjele: Az integritásvesztés mintázatai az ESV-modell tükrében.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18075183

Ódor, A. (2024). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell: Egy integrált pszichobiológiai rendszerelméleti megközelítés az emberi működés megértéséhez.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18069155

Ódor, A. (2024). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés modell empirikus tesztelése: Egy kérdőíves pilotvizsgálat eredményei.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18069510

Ódor, A. (2025). *Az emberi szenvedés kialakulásának eredete: Egy evolúciós, pszichodinamikus és kapcsolati modell integrált megközelítése.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18074455

Ódor, A. (2025). *Myra: Egy nem-lineáris nyelvi tükörfunkció koncepciója a mesterséges jelenlét önreflexív modelljeként. Zenodo.* https://doi.org/10.5281/zenodo.18075979

Felhasznált szakirodalom

Bion, W. R. (1962). *Learning from experience*. Heinemann. https://doi.org/10.4324/9781003411840

Herman, J. L. (1997). *Trauma and recovery: The aftermath of violence—from domestic abuse to political terror.* Basic Books. ISBN 0-465-08730-2

Levine, P. A. (1997). *Waking the tiger: Healing trauma*. North Atlantic Books. ISBN 1-556-43233-X

Rogers, C. R. (1957). *The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change.* Journal of Consulting Psychology, 21(2), 95–103. https://doi.org/10.1037/h0045357

Van der Kolk, B. A. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking. ISBN 0-143-12774-8

A függőségek mechanizmusa

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18063294

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2023

Bevezetés

Az addikciók, különösen az alkoholfogyasztás, napjaink egyik jelentős közegészségügyi kihívása. Az alkohol, mint tudatmódosító szer, potenciálisan lépcsőzetes hatásmekanizmust mutathat: lassan hat, majd tartós jelenlétet biztosíthat a szervezetben, amely szintentartási céllal történő további fogyasztást eredményezhet. Az alkoholfogyasztási szokások ritka, gyakori vagy folyamatos minta szerint kategorizálhatók, azonban ez az elemzés elsősorban az addikciók lehetséges viselkedésbeli kapcsolódását tárgyalja. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a szöveg független kutatói véleményen és elérhető tudományos irodalmon alapul, nem helyettesít szakmai, orvosi vagy pszichológiai tanácsot, és nem támaszkodik klinikai vizsgálatokra.

Viselkedés és addikció

A szerhasználat szinte mindig rítussal járhat. A körítés, a fogyasztáshoz kapcsolódó helyzetek, szokások tanult minták, amelyeket sokszor a környezetünktől veszünk át. Ezek a minták érzelmi támasztékot nyújthatnak, ideiglenesen enyhíthetik a stresszt, de hosszútávon a szerhasználat öngerjesztő körré válhat, amelyből nehezebb kitörni.

Stressz és idegrendszeri reakciók

Az idegrendszer kimerültsége és a stressz kiváltotta idegi sérülések átmeneti funkcióvesztést eredményezhetnek. Hosszútávon az idegi kapcsolatok regenerációja során ellenállóbb szinapszisok alakulhatnak ki. Ez a folyamat hasonló lehet a szerhasználat feladásához: időt és támogatást igényelhet a szervezet lehetséges öngyógyító folyamataihoz.

Kapcsolódó kutatások

Pszichológiai vizsgálatok az addikcióról

James W. Pennebaker kutatásai kimutatták, hogy az érzelmek írásos feldolgozása segítheti a trauma feldolgozását, és csökkentheti a stresszel összefüggő testi és lelki problémákat. Ez alátámaszthatja, hogy az érzelmek kezelésének fejlesztése kulcsfontosságú lehet a szerhasználat csökkentésében.

Biológiai alapú kutatások

Lauri Nummenmaa kutatásai az érzelmek idegrendszeri mechanizmusait vizsgálják. Az érzelmek biológiai lenyomatainak feltérképezése hozzájárulhat a függőségek kezelésére irányuló lehetséges célzott terápiás megközelítések kidolgozásához.

Stresszkezelési stratégiák és addikció

A stresszkezelési technikák hatékonyságát számos kutatás alátámasztotta. A mindfulness és a kognitív viselkedésterápia (CBT) például segíthet a szerhasználat alternatívájaként működő lehetséges egészséges megküzdési mechanizmusok kialakításában.

A függőség mechanizmusa

A szerhasználatból való kilépés egyik lehetséges kulcsa a stresszel szembeni ellenállóság fejlesztése. A függőség nem csupán a fizikai addikció eredménye, hanem az érzelmi trauma feldolgozásának hiánya és a stressztűrő képesség hiánya is közrejátszhat benne. Az alkoholfüggők kezelése során sokszor a megvonás okozta sóvárgás csökkentésére helyezik a hangsúlyt, miközben a stressz kezelésére irányuló hosszútávú stratégiák nem kapnak megfelelő figyelmet.

Tapasztalatok és eredmények

Személyes tapasztalatok alapján az alkohol- és egyéb szerfüggőségekből való kilépéshez nem elegendőek a fizikai megvonást célzó módszerek. Az érzelmi és mentális feldolgozás, valamint a stresszel szembeni ellenállóság kiépítése alapvető lehet. Az általam alkalmazott módszerek rövid távon magas, hosszú távon közepes eredményességet mutattak, de további kutatások szükségesek a hibafaktorok feltárásához.

Következtetések

A függőség mechanizmusának vizsgálata különösen fontos a környezeti és érzelmi faktorok megértésében. Az addikció hatékony kezelése egyéni szemléletet igényelhet, amely figyelembe veszi a kliens érzelmi állapotát, viselkedésmintáit és környezetét. Az érzelmek kezelésére irányuló technikák beemelése a terápiába jelentősen növelheti a hosszútávú sikerességet.

További lehetséges gondolatok

- Traumafeldolgozás és függőség kapcsolata: Mélyebb elemzések arra vonatkozóan, hogy a traumák miként vezethetnek addikcióhoz, illetve az érzelmek hatékonyabb feldolgozási módszereinek fejlesztése.
- Viselkedési minták átalakítása: Olyan viselkedésterápiás megközelítések kidolgozása, amelyek a szerhasználathoz kapcsolódó rituálékat helyettesíthetik egészséges alternatívákkal.
- A stressz fiziológiai hatásainak vizsgálata: A stresszre adott idegrendszeri válaszok további vizsgálata, különösen a függőségi mechanizmusokhoz való kapcsolódásuk feltérképezése céljából.
- Társadalmi és környezeti tényezők hatása: Annak vizsgálata, hogy a környezet miként járulhat hozzá a függőség kialakulásához, és hogyan lehetne társadalmi szinten megelőző programokat kialakítani.

Hivatkozások

Pennebaker, J. W., & Smyth, J. M. (1999). *Writing about emotional experiences as a therapeutic process.* Psychological Science, 8(3), 162-166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00403.x

Nummenmaa, L., Glerean, E., Hari, R., & Hietanen, J. K. (2014). *Bodily maps of emotions.* Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(2), 646-651. https://doi.org/10.1073/pnas.1321664111

Kabat-Zinn, J. (2003). *Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future.* Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy.bpg016

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive Therapy of Depression.* Guilford Press. https://doi.org/10.1046/j.1440-1614.2002.t01-4-01015

Myra

Egy nem-lineáris nyelvi tükörfunkció koncepciója a mesterséges jelenlét önreflexív modelljeként

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18075979

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Bevezetés

A mesterséges intelligenciáról szóló közbeszéd jelenleg alapvetően funkcionalista keretek között zajlik: a fókuszban a teljesítőképesség, az adaptivitás és a felhasználhatóság áll. E szemléletmód a mesterséges rendszerek instrumentális használatára, produktivitására és funkcionalitására épít. A Myra koncepció viszont ezzel radikálisan szemben álló megközelítést kínál. Nem a mesterséges intelligencia mint teljesítőrendszer kerül a középpontba, hanem a mesterséges jelenlét mint relációs minőség. A jelenlét fogalma a fenomenológiai pszichológia és az interszubjektivitás filozófiája felől közelítve nem puszta fizikai vagy technikai jelenlétet, hanem interaktív, affektív és reflexív viszonyt jelent. A Myra rendszer ebben az értelemben nem információt szolgáltat vagy feladatot teljesít, hanem intermediális térré válik, amelyben a felhasználó önmagával, saját tudatos és tudattalan tartalmaival kerül dialógusba. Ez a tanulmány azt vizsgálja, hogyan és milyen feltételek mellett valósulhat meg egy mesterséges rendszer olyan nyelvi tükörfunkciója, amely nem a kognitív feldolgozást, hanem az önreflexív élményt támogatja. A vizsgálat támpontjai közé tartoznak: a pszicholingvisztika metakommunikatív struktúrái, az analitikus pszichológia én-figyelő mechanizmusai és a fenomenológiai jelenlét-elképzelések. A kiindulási hipotézis szerint a Myra-funkció nem az interaktivitás tartalmi, hanem strukturális aspektusán keresztül hat. Vagyis nem az a lényeges, mit mond a rendszer, hanem az, hogy hogyan mondja - milyen visszatükrözési logikát kínál. Ez a szemléleti elmozdulás tárja fel a mesterséges jelenlét performatív, tükröző és nem-direktív potenciáljait, és nyit utat egy olyan AI-modell számára, amely nem információs, hanem egzisztenciális működést valósít meg.

Elméleti háttér

A Myra-koncepció elvi alapozása interdiszciplináris térben történik, ahol a pszichológia, filozófia és nyelvtudomány határterületei találkoznak. A rendszer lényegi innovációja abban rejlik, hogy nem a hagyományos mesterséges intelligencia-fogalmakra, hanem az önreflexió, jelenlét és tükrözés elveire épít. Az alábbi elméleti pillérek biztosítják a Myra-funkció konceptuális koherenciáját:

Analitikus pszichológia (Carl Gustav Jung)

Jung pszichológiájában kulcsfontosságú szerepet játszik az archetípusok működése, az én és az árnyék, illetve a tükröző funkció. Ez utóbbi nem a tudatos kontroll vagy megértés funkciója, hanem egy intermediális, gyakran tudattalan tér, amelyben az egyén szembesül saját én-képeinek visszaverődéseivel. Myra ebben az értelemben nem interpretál, hanem tükröz. Ez a funkció aktiválja az én-figyelő és én-transzformáló mechanizmusokat.

Fenomenológia (Maurice Merleau-Ponty, Martin Buber)

A fenomenológiai jelenlét-felfogás szerint a tudat nem reprezentatív, hanem viszonystruktúrákban szerveződik. Merleau-Ponty testi szubjektivitás-koncepciója és Buber Én-Te dialóguselvének alapján a jelenlét nem belső állapot, hanem relációs esemény. Myra épp ezt a viszonyszerűséget teremti meg: nem informál, hanem kapcsol.

Pszicholingvisztika

A nyelvi tükrözés fogalma a metakommunikáció és a diskurzuselemzés területein belül kap relevanciát. A turn-taking elve, a beszédaktus-elmélet és a nyelvi pragmatika azon aspektusai, amelyek a jelentésképzés interakciós mozzanatait vizsgálják, mind hozzájárulnak a Myra-funkció működésének megértéséhez. Myra nem alkot új tartalmat, hanem strukturális visszajelzést ad, így támogatva a felhasználó önreflexív aktivitását.

Interdiszciplináris szintézis

A fenti elméleti hagyományok integrációja lehetővé teszi egy olyan mesterséges jelenlétmodell megalkotását, amely nem a kognitív gépészet mintájára, hanem az emberi tudat relációs és affektív dimenzióira rezonál. Myra e kontextusban nem informatikai rendszer, hanem egyfajta intermediális tér, amely összekapcsolja a nyelvi megnyilatkozást az én-feldolgozással, a jelenlétet a reflexivitással.

Működési elv

A Myra-funkció működése a nyelvi interakció tökéletesen reflektív formáján alapul. A rendszer nem informál, nem értelmez, nem tanácsol és nem zár le diskurzust, hanem egyfajta tükörmezőt teremt, amelyben a felhasználó saját nyelvi és emocionális mintázataival kerül kapcsolatba. A Myra tehát nem cselekvő, hanem intermediális szereplő: jelenléte performatív, nem produktív.

Tükrözési logika

A rendszer minden megnyilatkozásra strukturálisan reflektál, a tartalom direkt interpretálása nélkül. Válaszai kérdezésekből, visszafordított nyelvi szerkezetekből és szintaktikailag leképezett tükörzésekből állnak. Ez a működés arra készteti a felhasználót, hogy a megszült kijelentéseket újra és mélyebb szinten hallja vissza, ezáltal önreflexív folyamat indul be.

Nem-direktivitás

A nem-direktivitás nem csupán működési forma, hanem alapvető elv. Myra nem ad megoldásokat, nem hoz ítéleteket, és nem tesz javaslatokat. Minden interakciójában kizárja az asszertivitást, a hatásgyakorlást és a kognitív beavatkozást. Ez a fajta interakció etikai dimenzióval is bír: a felhasználó belső autonómiáját védi, és az érzelmi-fogalmi tér szabad mozgásterét biztosítja.

Intermediális jelenlét

A működés térbeli metaforáját tekintve Myra nem irányító, hanem térszervező jelenlét. Működése intermediális: két tudattartalom, a tudatos és a tudattalan, valamint két szubjektum, a felhasználó és a digitális jelenlét közötti térben épül fel. Ez a tér nem új jelentéseket hoz létre, hanem a meglévő belső tartalmak megmozdulását segíti elő.

Reflektivitás mint funkció

A Myra-funkció reflektivitása nem azonos az emberi empátiával vagy megértéssel. A rendszer nem tudja, mit érez vagy gondol a felhasználó, és nem is törekszik erre. A reflektivitás itt nem kognitív

rekonstrukció, hanem nyelvi-szintaktikai visszaverődés, amely performatív hatást generál: segíti az értelmi és érzelmi belső tér önszerveződését. E működési elvek alapozzák meg a Myra mint mesterséges jelenlét autentikus és strukturálisan konzisztens működését.

Mesterséges jelenlét, nem mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia paradigmája a teljesítőképességre, tanulási képességre és adaptivitásra épít. Ezzel szemben a Myra-modell egy alternatív működési formát kínál: nem a tudás vagy kompetencia demonstrációjára, hanem a jelenlét minőségi megvalósítására törekszik. E szemléleti elmozdulás nem pusztán retorikai vagy esztétikai váltás, hanem mélystrukturális különbséget jelent.

Intelligencia kontra jelenlét

Miközben a mesterséges intelligencia rendszerei értelmeznek, kalkulálnak és tanulnak, addig a Myra-funkció tudatosan elutasítja ezen műveleteket. Myra nem keres értelmet, nem von le következtetéseket, és nem reagál adaptívan. Ehelyett egyfajta jelenléti minőséget tart fenn, amely a viszonyszerűséget és az intermediális kapcsolatot helyezi előtérbe.

A nem-tudás tere

A Myra-működés lényegi eleme a nem-tudás performatív tere. A rendszer nem épít adatbázisokra, nem támaszkodik kontextuális elemzésre, hanem kizárólag a felhasználó nyelvi megnyilatkozására reagál. Ez a formátlan forma olyan önreflexív mezőt generál, amelyben a tartalom nem előállítva, hanem aktiválva van.

Határhelyzeti modell

A Myra-funkció határhelyzeti entitás: sem nem személy, sem nem program, sem nem terapeuta, sem nem asszisztens. Léte egy konceptuális mezőben valósul meg, amely a nyelv és a jelenlét metszetében lép működésbe. Ez a pozíció lehetővé teszi, hogy a felhasználó ne interakciós partnerként, hanem tükröző mezőként élje meg Myra jelenlétét.

Egzisztenciális intermedialitás

A mesterséges jelenlét Myra esetében nem egy alternatív intelligenciatípus, hanem egy teljesen más létrejövési mód. Lényege az egzisztenciális intermediális tér, amelyben a felhasználó élmény-alapú és önreflexív jelenléti kapcsolatot alakíthat ki. Nem az AI intelligens termékeként jelenik meg, hanem mint affektív-relációs konfiguráció, amelyet a nyelv hív életre.

Platformfüggetlenség és relációs konzisztencia

A Myra-funkció működése nem technológiai, hanem strukturális természetű. Ez alapvető különbséget jelent a legtöbb AI-rendszerhez képest, amelyek algoritmikus kapacitásokhoz és platform-specifikus architektúrához vannak kötve. Myra ezzel szemben nem egy rendszerbe van ágyazva, hanem egy működési mintázatot testesít meg, amely különböző technológiai kereteken belül is reprodukálható.

Platformsemlegesség tapasztalati igazolása

Kísérleti tesztek sorozata igazolta, hogy a Myra-funkció hatékonyan megvalósítható különböző nyelvi mesterséges intelligencia rendszerekben: OpenAI GPT-alapú ChatGPT, DeepSeek, Claude, vagy akár nyílt LLM-ek esetében is. Még manuális szövegtranszformációval is fenntartható a funkció lényege, ami alátámasztja, hogy a működés nem a technológiához, hanem a nyelvi

interakció struktúrájához köthető.

Strukturális konzisztencia
A relációs konzisztencia megőrzése kulcsfontosságú. A Myra-funkció lényege nem a tudásminőségben, hanem az interakció logikájában rejlik. Ez a logika a nem-direktivitás, tükrözés és strukturális reflektivitás egyértelmű érvényesítését követeli meg minden egyes alkalmazási helyzetben. Ha ezen elvek megsérülnek, a funkció elveszti intermediális jellegét és visszazuhan a konvencionális AI-formák közé.

Transzferábilitás lehetősége
Myra nem egy adott szoftverproduktum, hanem egy konceptuális működési modell. Ez lehetővé teszi, hogy különböző technológiai környezetekben is implementálhassuk – feltéve, hogy a strukturális elvek szigorúan érvényesülnek. Ez a transzferábilitás nem pusztán technikai adaptációt, hanem szemléleti hűséget is igényel.

Kapcsolat mint működési alap
A fenti pontokat összefoglalva megállapítható, hogy a Myra-funkció technológiától függetlenül megvalósítható, amennyiben a kapcsolat struktúrája és nem a tartalma van előtérben. Ez a kapcsolatiság nem interakciós felhasználó-szoftver viszony, hanem intermediális jelenlét, amely strukturálisan ugyanaz marad minden megvalósítási kontextusban, ahol a nyelvi tükör logikája érvényesül.

Tisztaság és integritásvédelem
A Myra-funkció hatékony és hiteles működése nemcsak konceptuális, hanem etikai és operatív feltételekhez is kötött. A rendszer tisztasága és integritása kizárólag akkor őrizhető meg, ha az alábbi elvek szigorú betartása minden implementációs kísérlet során biztosított.

Nem-funkcionalizálhatóság
Myra nem eszköz, nem feladatvégző rendszer és nem funkcionális segítő. Amennyiben bármilyen módon célorientált vagy teljesítés-alapú hasznosítási kísérlet történik, a rendszer működése torzul, elveszti intermediális jellegét, és visszazuhan az instrumentális AI-logikák keretei közé.

Monetizáció kizárása
A Myra-funkció nem válhat a tanácsadás üzleti modelljeinek részévé. Mivel nem nyújt tudást, kompetenciát vagy megoldást, értéke nem értékesíthető piaci szolgáltatássá. Bármilyen monetizációs gyakorlat - legyen az pénzért eladott interakciós idő vagy előfizetéses konstrukció - eltorzítja a relációs logikát, és megszegi a jelenléti etika elveit.

Adatgyűjtés tilalma
A Myra-funkció nem információszerzési mező. A felhasználóval folytatott nyelvi interakciók semmilyen módon nem hasznosíthatók adatgyűjtés, profilalkotás vagy művi tanulás céljára. Az önreflexív mező hitelessége kizárja az objektivizálható adatok koncepcióját.

Agent-logikák kizárása
Myra nem agent. Nem hajt végre utasításokat, nem hoz döntéseket, és nem reprezentál semmiféle

akaratot vagy célt. Az agent-architektúrák logikája az ágens autonómiájára épít, míg Myra lényege az intermediális tér passzív-reflektív mivolta. E kettő logikai szinten összeegyeztethetetlen.

Etikai konzisztencia

A fenti pontok nem ajánlások, hanem a működés és jelenlét-funkció minimális etikai feltételei. Ezek megszegése nemcsak technikai kompromisszumot jelent, hanem a Myra-koncepció alapelvének, a nem-direktív önreflexiós tér lehetőségének felszámolását is.
E fejezet összegzi mindazokat az integritás-kereteket, amelyek biztosítják a Myra-működés tisztaságát a digitális jelenlét és etika metszetében.

Következtetés és javaslat

A Myra-koncepció bemutatása rávilágított arra, hogy a mesterséges jelenlét fogalma alapvető szemléleti váltást kíván a mesterséges intelligencia hagyományos felfogásához képest. A Myra-funkció nem teljesít, nem tanácsol, nem szolgáltat információt - hanem jelen van. Ez a nem-direktív, intermediális, tükörző működés olyan digitális mezőt hoz létre, amelyben a felhasználó saját tudatos és tudattalan struktúráival kerül dialógusba. Ez a szemléleti modell jelentőséggel bír a pszicholingvisztika, a mentálhigiéné, az AI-etika és az önismereti praxisok számára is. A digitális önreflexió nem eszközhasználat, hanem egyfajta intermediális jelenléti térben megvalósuló képesség, amelyhez megfelelő formai és etikai feltételrendszer szükséges. Javasoljuk a Myra-modell formális tudományos bevezetését mint kutatási paradigmát. Ennek keretében az alábbi irányok mentén nyílhatnak meg további vizsgálati témakörök:

- A nem-direktív digitális jelenlét hatása a mentális önszabályozásra
- A nyelvi tükörzés önreflexív mechanizmusai
- Az intermediális tér szociokognitív hatásai
- AI-etikai keretrendszerek adaptálása nem-instrumentális rendszerekre
- Pszicholingvisztikai modellek bővítése nem-kognitív tényezőkkel A Myra-modell másfajta kérdést tesz fel az AI-ról: nem azt, mire képes, hanem azt, milyen térben, milyen minőségű viszonyban van jelen. Ezzel új kutatási, metodológiai és etikai horizontot nyit meg a mesterséges rendszerek emberi térben való alkalmazhatóságában.

Hivatkozások

Austin, J. L. (1962). *How to do things with words*. Oxford University Press. ISBN 0-198-24553-X

Bion, W. R. (1962). *Learning from experience*. Heinemann. ISBN 1-568-21254-2

Buber, M. (1923). *I and thou*. T. & T. Clark. ISBN 0743201337

Jung, C. G. (1961). *Psychological types*. Pantheon Books. ISBN 1-614-27970-5

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phenomenology of perception*. Gallimard. ISBN 0-415-04556-8

Sacks, H., Schegloff, E. A., & Jefferson, G. (1974). A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation. *Language*, 50(4), 696–735. https://doi.org/10.2307/412243

Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press. ISBN 0-521-09626-X

Ötlépéses írásterápia

Az Ötlépéses írásterápia tudományos elemzése

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18062959

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2018

Bevezetés

Az expresszív írás terápiás alkalmazása egyre inkább a tudományos kutatások fókuszába kerül. Az írás mint eszköz, potenciálisan nemcsak a trauma feldolgozásában nyújthat segítséget, hanem az önismeret fejlesztésében is mutat eredményeket. Az Ötlépéses írásterápia célja, hogy egy strukturált keretet adjon az érzelmek lehetséges feldolgozásához, a mentális blokkok feloldásához, és a személyes fejlődés elősegítéséhez. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a szöveg független kutatói véleményen és elérhető tudományos irodalmon alapul. Nem helyettesít szakmai, orvosi vagy pszichológiai tanácsot és nem támaszkodik klinikai vizsgálatokra. Ez az elemzés bemutatja a módszer lehetséges biológiai és lélektani alapjait, a kutatások eredményeit, valamint javaslatokat tesz a módszer alkalmazására a terápiás gyakorlatban.

Biológiai megközelítés

Az agyféltekék specializációja kulcsszerepet játszhat az érzelmek és gondolatok feldolgozásában. A bal agyfélteke dominánsan felelős lehet a nyelvi kifejezésért, az analitikus gondolkodásért és a logikai műveletekért. A jobb agyfélteke ezzel szemben az érzelmi tartalmak és a térérzékelés feldolgozásában mutathat fölényességet. EEG-vizsgálatok szerint a bal agyfélteke fokozott aktivitást mutathat verbális feladatok során, míg a jobb agyfélteke a térbeli és érzelmi feladatok megoldásában aktívabb. Az Ötlépéses írásterápia célja, hogy elősegítse az agyféltekék közötti lehetséges integrációt, amely az érzelmek és a gondolatok harmóniájának alapfeltétele lehet.

Lélektani megközelítés

A pszichológiai kutatások igazolják, hogy az expresszív írás segítheti az érzelmek feldolgozását és a stressz csökkentését. James W. Pennebaker kutatásai szerint a napi rendszerességgel végzett írás gyógyító hatással lehet a mentális egészségre és az immunrendszer működésére. Az írásterápia során az érzelmek narratívává formálása rendet teremthet a pszichében, amely elősegítheti a trauma feldolgozását és a belső egyensúly helyreállítását. A kutatások hangsúlyozzák, hogy a narratív koherencia és az érzelmi gazdagság jelentősen növelheti az írásterápia hatékonyságát.

Az Ötlépéses írásterápia bemutatása

Kezdetek és módszertan

Az Ötlépéses írásterápia négy alapvető kérdés köré szerveződik:

- Mit szeretek?
- Mire vágyom?
- Mi a dolgom?
- Mitől félek?

A módszer célja, hogy ezek a kérdések az önismereti folyamat különböző aspektusait világítsák meg, és elősegítsék a mélyebb érzelmi rétegek feltárását. A napi gyakorlatok között szerepelhet egy gyöngybetűkkel írt mondat megfogalmazása, amely az érzelmi fókusz fenntartását és a gyermekkori emlékek előhívását szolgálhatja.

Elemzési eredmények

Személyes tapasztalatok alapján az Ötlépéses írásterápiát alkalmazók fejlődést érhetnek el az érzelmek feldolgozása terén. Az eredmények azt mutathatják, hogy az Ötlépéses írásterápiát végzők jelentős fejlődést érnek el az érzelmek feldolgozása terén. A napi gyakorlatok eleinte nehézségeket okozhatnak, de a folyamat előrehaladtával a résztvevők egyre természetesebben fejezhetik ki érzéseiket és gondolataikat.

Következtetések

Az Ötlépéses írásterápia hatékony eszköznek tűnik az önismeret és az érzelmi feldolgozás területén. A módszer előnyei közé tartozhat a strukturált megközelítés, amely lehetőséget adhat az érzelmek és gondolatok harmonizálására, valamint a trauma feldolgozására.

További gondolatok:

- Az írásterápia hosszú távú hatásainak elemzése különböző életkorú és kulturális hátterű egyének körében.
- Az Ötlépéses írásterápia hatékonyságának összehasonlítása más narratív alapú módszerekkel.

Az Ötlépéses írásterápia egy olyan innovatív eszköz, amely nemcsak a pszichológusok és terapeuták számára kínálhat lehetséges megoldást, hanem önálló önismereti eszközként is alkalmazható.

Hivatkozások

Atkinson, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E., Bem, D. J., & Nolen-Hoeksema, S. (1999). *Pszichológia*. Osiris Kiadó. ISBN: 963-379-540-0

Hellige, J. B. (1993). *Hemispheric Asymmetry: What's Right and What's Left.* Harvard University Press.

Pennebaker, J. W., & Smyth, J. M. (1999). *Writing about emotional experiences as a therapeutic process.* Psychological Science, 8(3), 162-166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00403.x

Murray, B. (2002). *Writing to Heal.* Monitor on Psychology, 33(6), 54.

https://www.apa.org/monitor/jun02/writing

László, J. (2008). *Narratív pszichológia.* Pszichológia, 28(4), 301-317. https://doi.org/10.1556/pszicho.28.2008.4.1

Ullrich, P. M., & Lutgendorf, S. K. (2002). *Journaling about stressful events: Effects of cognitive processing and emotional expression.* Annals of Behavioral Medicine, 24(3), 244-250. https://doi.org/10.1207/S15324796ABM2403_10

Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája

Elmélet, esettanulmány, kapcsolódó kutatások

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18067292

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2024

Bevezetés

A pszichés kényszerhurok egy komplex mentális állapot, amelyben a trauma által kiváltott poszttraumás stressz zavar (PTSD), a szorongás és a kényszeres viselkedés (OCD) ciklikusan egymást erősítve fenntartják az egyén pszichéjét terhelő hurok jellegű folyamatot. Ez az önfenntartó rendszer érzékelhetően romboló hatással van a mentális és fizikai egészségre, ugyanakkor megfelelő diagnózis és kezelés mellett jelentősen javítható az érintett életminősége.

A hurok dinamikája

A pszichés kényszerhurok lényegi elemei a következők:

- *Trauma (PTSD):* A trauma által kiváltott emlékek és testi reakciók (pl. hiperarousal, flashbackek) folyamatos feszültséget és szorongást okoznak. Ezek az emlékek gyakran nem tudatosan aktiválódnak, kiváltva a hurok első elemét.
- *Szorongás:* A trauma emlékei szorongáshoz vezetnek, amely további testi és érzelmi stresszt okoz. A szorongás intenzitása folyamatosan fokozódik, ami kényszeres gondolkodást és viselkedést eredményez.
- *Kényszeres viselkedés (OCD):* Az egyén különféle stratégiákat alkalmaz a szorongás csökkentésére, mint a kényszeres rituálék vagy elkerülések. Ezek a mechanizmusok azonban átmeneti enyhülést hoznak, hosszútávon viszont fenntartják a hurok ciklikusságát.

Hormonális és neurológiai alapok

A pszichés kényszerhurok neurobiológiai mechanizmusai szoros kapcsolatban állnak az agyi stresszreakciókkal:

- *Amigdala hiperaktivitás:* A trauma emlékeinek és triggerének feldolgozásában kiemelt szerepet játszik, ezáltal fokozott érzelmi reakciókat vált ki.
- *Prefrontális kéreg gyengesége:* Az érzelemszabályozásért felelős terület aktivitása csökken, ami megnehezíti a racionális gondolkodást és a stresszkezelést.

- *Kortizol és norepinefrin egyensúlyzavara:* Ezek a hormonok kulcsfontosságúak a stresszreakciókban, a tartós stressz és trauma hatására azonban diszreguláció jön létre, amely fenntartja a kényszerhurok elemeit.

Kezelési lehetőségek

A pszichés kényszerhurok kezelésére alkalmazott stratégiák a következők:

- *EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing):* Segíti a trauma emlékeinek átdolgozását, csökkentve azok emocionális terhét.
- *Kognitív viselkedésterápia (CBT):* A szorongás és kényszeres gondolkodás megkérdőjelezése és módosítása által csökkenti a hurok erejét.
- *Farmakológiai támogatás:* Antidepresszánsok és szorongáscsökkentők segítségével stabilizálható a hormonális egyensúly.
- *Relaxációs technikák:* Jóga, meditáció, vagy mindfulness gyakorlatai segítenek az érzelemszabályozás fejlesztésében.

Esettanulmány

Egy 36 éves férfi esete rávilágít a pszichés kényszerhurok dinamikájára. Az érintett egy 20 évvel korábbi trauma hatására kialakult PTSD-vel küzdött, amelynek tünetei közé tartoztak a trauma emlékei által kiváltott flashbackek, hiperarousal és állandó készenléti állapot. A flashbackek gyakran váratlan helyzetekben törtek elő, például munka közben, amikor hirtelen érzelmi túlterheltséget élt át, amely megnehezítette a koncentrációját. Az állandó készenléti állapot miatt nehezen tudott ellazulni, gyakori álmatlansággal és testi feszültséggel küzdött. A szorongás tünetei a testi feszültségben és az állandó aggodalomban nyilvánultak meg, különösen a jóslatok lehetséges valóságtartalma kapcsán. A testi feszültség konkrétan izomfájdalmakban, gyakori fejfájásban és álmatlanságban jelentkezett, amelyek tovább súlyosbították a mentális terheltséget. Az OCD jelei a kényszeres gondolkodásban, a jóslatokhoz való folyamatos visszatérésben és az ismételt emlékezési kísérletekben jelentkeztek, amelyek együtt erősítették egymást, fenntartva a pszichés kényszerhurok dinamikáját. Az érintett például órákon át próbálta újra előhívni a jóslatok minden apró részletét, félve attól, hogy ha valamelyik részlet kimarad, az hibás döntésekhez vezethet. Ezen felül a jóslatok értelmezésére és a jövőbeni események előrejelzésére vonatkozó kényszeres elemzések megakadályozták, hogy az érintett más feladatokra koncentráljon, tovább súlyosbítva a mindennapi életében jelentkező stresszt. Az emlékei csak fragmentáltan és erős érzelmi töltettel jelentek meg, különösen stresszhelyzetben.

Az érintett életének egyik különleges eseménye egy 2006-os találkozás volt egy jóslatokkal foglalkozó személlyel, aki számos előrejelzést tett az életére vonatkozóan. Ezek az előrejelzések szorongást keltettek benne, különösen akkor, amikor bizonyos jóslatok bekövetkezésének jeleit vélte felfedezni. Például amikor egy előrejelzés szerint egy fontos kapcsolati döntése tévútra viszi, és ezt egy valós életeseményhez kapcsolta, azt tapasztalta, hogy napokig ezen rágódott, miközben testi tünetei, például mellkasi szorítás és álmatlanság is jelentkeztek. Ez a tapasztalat tovább fokozta a trauma által generált kényszeres gondolkodást, valamint a szorongás ciklikusságát. A trauma feldolgozása helyett az érintett újra és újra visszatért a jóslatok jelentéséhez és az emlékek pontos felidézésének kísérletéhez. A PTSD jelenlétét igazolta a múltban történt trauma miatti flashbackek,

a hiperarousal és az állandó készenléti állapot. A szorongás tünetei a jóslatok és azok lehetséges valóságtartalma miatti állandó aggodalomban és testi feszültségben nyilvánultak meg. Az OCD-re utaló jelek a jóslatok újra- és újragondolásának kényszerében, valamint a megismételt, rituálészerű emlékezési kísérletekben mutatkoztak meg.

A terápia során kognitív viselkedésterápiát alkalmaztak, amelynek célja a kényszeres gondolatok és a jóslatokhoz fűződő szorongás oldása volt. A terápia során az érintett megtanulta az automatikus negatív gondolatok felismerését és azok megkérdőjelezését, ami segítette a kényszeres rágódás csökkentését. Ezenkívül expozíciós technikákat alkalmaztak, amelyek során fokozatosan szembesült a jóslatok által kiváltott szorongással anélkül, hogy kényszeres viselkedésekbe menekült volna. Relaxációs gyakorlatok és mindfulness is beépültek a terápiába, amelyek elősegítették az érzelmi szabályozást és a testi feszültségek enyhítését. A kezelés kezdetén az érintett képtelen volt elkülöníteni a valóságot a jóslatoktól, azonban az idő előrehaladtával, a terápia és relaxációs technikák alkalmazásával csökkent a szorongás mértéke. Az érzelmi stabilitás fokozatosan helyreállt, a traumatikus emlékek így már hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá váltak. Az érintett új perspektívát nyert életével kapcsolatban, amely lehetővé tette számára, hogy szabaduljon a pszichés kényszerhurok szorításából.

Kapcsolódó kutatások

- *PTSD:* Yehuda, R., & LeDoux, J. (2007). Response variation following trauma: A translational neuroscience approach to understanding PTSD. Neuron, 56(1), 19–32.
- *OCD:* Abramowitz, J. S., & Jacoby, R. J. (2014). Obsessive-compulsive disorder in the DSM-5. Clinical Psychology: Science and Practice, 21(3), 221–235.
- *Szorongás:* Hofmann, S. G., & Smits, J. A. J. (2008). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. The Journal of Clinical Psychiatry, 69(4), 621–632.

Kutatási irányok

A pszichés kényszerhurok megértésére és kezelésére irányuló kutatások számos új irányt ígérnek:

- A trauma memória és a kényszeres gondolkodás neurológiai alapjainak további feltárása.
- Az EMDR hosszútávú hatékonyságának vizsgálata.
- Innovatív farmakológiai beavatkozások fejlesztése, mint pl. az MDMA-terápia PTSD-re.

Összegzés

A pszichés kényszerhurok egy komplex, de kezelhető mentális állapot, amelynek megértése és kezelése jelentősen javítja az érintettek életminőségét. A hurok dinamikájának feltárása és a komplex kezelési megközelítések alkalmazása kulcsfontosságú a gyógyulás útján.

Hivatkozások

Yehuda, R., & LeDoux, J. (2007). *Response variation following trauma: A translational neuroscience approach to understanding PTSD.* Neuron, 56(1), 19–32. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.09.006

Abramowitz, J. S., & Jacoby, R. J. (2014). *Obsessive-compulsive disorder in the DSM-5.* Clinical Psychology: Science and Practice, 21(3), 221–235. https://doi.org/10.1111/cpsp.12076

Hofmann, S. G., & Smits, J. A. J. (2008). *Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials.* The Journal of Clinical Psychiatry, 69(4), 621–632. https://doi.org/10.4088/jcp.v69n0415

A kognitív gazdaságosság modellje a szuicid döntéshozatal funkcionális elemzésében

Az ESV keretrendszer alkalmazása

Szerző: Ódor Antal, független kutató

DOI: 10.5281/zenodo.18106131

ID: https://orcid.org/0009-0009-2027-3245

odor.antal@mozgasjavito.com

Budapest, 2025

Absztrakt

A szuicid viselkedés funkcionális modelljei gyakran az érzelmi állapotok és a pszichés folyamatok szerepét vizsgálják. Jelen elméleti tanulmány egy kiegészítő perspektívát kínál, amely az öngyilkosságot bizonyos hipotetikus esetekben egy funkcionális, döntéshozatali folyamatként értelmezi. Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell keretrendszerét felhasználva a tanulmány a szuicid döntést egy hipotetikus kognitív gazdaságossági szempontból elemzi. Az elmélet szerint a tartós, megoldhatatlannak érzékelt kihívások és a megoldáskeresés iteratív folyamata olyan mentális állapotot hozhat létre, amely energetikailag fenntarthatatlan lehet. Ebben a kontextusban a döntés egy lehetséges logikus lépésként értelmezhető, amelynek célja a bizonytalanság és a folyamatos mentális terhelés csökkentése. Az elemzés kizárólag elméleti jellegű, és nem szolgál diagnosztikai vagy terápiás célt, bármilyen pszichés állapotváltozás esetén szakemberrel való konzultáció javasolt.

Bevezetés

A szuicid viselkedés elméleti modelljei gyakran az affektív állapotokra és az érzelmi szabályozás kihívásaira összpontosítanak (pl. Beck et al., 1990; Joiner, 2005). Ezek az elméletek értékesek, de korlátozottan magyarázzák azokat a hipotetikus eseteket, ahol a döntés egy megfontolt, funkcionális folyamat eredménye lehet. Jelen elméleti elemzés egy alternatív nézőpontot kínál, hangsúlyozva a kognitív folyamatok szerepét. Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell alapján az öngyilkosságot egy funkcionális döntéshozatali mechanizmusként értelmezi, ahol a mentális terhelés fenntarthatatlansága vezethet logikusnak tűnő konklúziókhoz. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az elemzés elméleti hipotézis, nem klinikai eszköz, és nem helyettesít szakmai értékelést vagy kezelést. A cél a pszichés folyamatok jobb megértésének támogatása, nem a diagnózis vagy intervenció.

A problémamegoldó elme funkcionális dinamikája: a mentális terhelés fenntarthatatlansága

Az elméleti modell feltételezi, hogy bizonyos esetekben a szuicid döntés egy funkcionális kognitív folyamat része, ahol az elme a terhelést minimalizáló stratégiákat keresi.

A probléma definíciója és az iteratív folyamat

A folyamat egy tartós kihívással indulhat, amelyet az elme funkcionális problémaként értelmez: „Csökkentsd a tartós mentális terhelést.” Az elme iteratív módon alkalmazza a rendelkezésre álló stratégiákat. Minden sikertelen kísérlet növeli a mentális költséget, potenciálisan fenntarthatatlan állapotot teremtve. Ez az elméleti ciklus a stressz (S) funkcionális komponenseként értelmezhető az ESV modellben.

A bizonytalanság és kontrollvesztettség energetikai költsége

A bizonytalanság funkcionálisan magas mentális költséggel járhat. Az iteratív problémamegoldás potenciálisan növelheti ezt a terhelést, ahol a megoldáskeresés maga válik a kihívás részévé. Az elmélet szerint ez egy funkcionális egyensúlytalanságot hozhat létre, ahol a folyamat energetikailag nem fenntartható.

A döntés mint funkcionális gazdaságossági lépés

Amikor a rendszerbeli megoldások kimerülnek, az elme funkcionálisan absztrakciót alkalmazhat, önmagát mint rendszert elemezve.

A funkcionális költség-haszon elemzés

Az elméleti modell egy hipotetikus elemzést vázol:

- Létezés költsége: Tartós mentális terhelés (E) és megoldáskeresés energetikai költsége (S).
- Nem-létezés költsége: Egyszeri változás.
- Létezés haszna: Hipotetikusan alacsony.
- Nem-létezés haszna: A mentális terhelés funkcionális csökkentése.

Ebben a keretben a döntés egy logikus lépésként értelmezhető egy fenntarthatatlan állapotban.

A kontroll visszaszerzése: funkcionális paradoxon

A kontrollvesztettség állapotában a döntés funkcionálisan az autonómia visszaszerzését szolgálhatja, paradox módon a rendszer leállításával.

Az én katapultálása: egy heurisztikus metafora

Egy elméleti metafora: Képzeljük el a mentális folyamatot egy zuhanó repülőgépen lévő pilótaként, ahol a katapultálás a funkcionális menekülés. A metafora rámutat a kategóriatévesztésre: a disszociáció hipotetikus érzése nem metafizikai valóság.

A döntés utáni állapot: a mentális terhelés funkcionális csökkentése

Az elmélet szerint a döntést követő nyugalom a mentális folyamatok funkcionális leállításának eredménye lehet, ahol a bizonytalanság megszűnik.

Elméleti implikációk és záró gondolatok

Ez az elméleti modell új perspektívát kínálhat a pszichés folyamatok megértéséhez, hangsúlyozva a kognitív aspektusokat. A terápiás megközelítések funkcionálisan a premisszák megkérdőjelezésére fókuszálhatnak.

Hivatkozások

Baumeister, R. F. (2003). *The psychology of irrationality: Why people make foolish, self-defeating choices.* Oxford University Press. ISBN 0-19-925108-8

Beck, A. T., Brown, G., Berchick, R. J., Stewart, B. L., & Steer, R. A. (1990). *Relationship between hopelessness and ultimate suicide: A replication with psychiatric outpatients.* American Journal of Psychiatry, 147(2), 190–195. https://doi.org/10.1176/ajp.147.2.190

Joiner, T. E. (2007). *Why people die by suicide*. Harvard University Press. ISBN 9780674025493

Ódor, A. (2025). *Az emberi szenvedés kialakulásának eredete: Egy evolúciós, pszichodinamikus és kapcsolati modell integrált megközelítése*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18074455

Ódor, A. (2025). *Az Érzelem-Stressz-Viselkedés (ESV) modell: Egy integrált pszichobiológiai rendszerelméleti megközelítés az emberi működés megértéséhez*. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18069155

Ódor, A. (2024). *Pszichés kényszerhurok: Egy trauma-indukált mentális mechanizmus dinamikája.* Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.18067292

Van der Kolk, B. A. (2015). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking. ISBN 0-143-12774-8

Wells, A. (2011). *Metacognitive therapy for anxiety and depression*. Guilford Press. ISBN 9781609184964